



Malang, 30 Desember 2025

Nomor : 1194/I-PM/KB-YAN/XII/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Penambahan Berkas Formulir Rekam Medis

Kepada Yth.

Komite Rekam Medis RS Prima Husada Malang

Di Tempat

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb
Bagian : Kepala Bidang Pelayanan Medis
mengajukan (**penambahan**)* berkas formulir rekam medis, yaitu:
Judul No Formulir : **FORM OBSERVASI BALANCE CAIRAN**

Keterangan : Mendokumentasi tindakan resusitasi pada pasien kondisi henti jantung dan sinkron dengan lembar observasi hingga pasien *codeblue*

Alasan Pengajuan : Dokumentasi yg blm terstruktur (data dari temuan lapsus)

Kami memberikan contoh format berkas formular rekam medis yang dimaksudkan dalam bentuk *soft copy*. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pelayanan Medis



Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb



Lampiran : I (Satu)
Nomor : 1194/I-PM/KB-YAN/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

PROSES PENAMBAHAN REKAM MEDIS

Nama Formulir Rekam Medis

Tanggal	Pokok Bahasan	Tanda tangan
23 Desember 2025	Penambahan Lembar OBSERVASI BALANCE CAIRAN	-

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pelayanan Medis



Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb



Berat Badan : ____ kg

Diagnosa : _____ ☐ Gagal Jantung ☐ Gagal Ginjal (CKD) ☐ Luka Bakar ☐ DHF

[illegible]

Total:

➤ IWL:	0-6 bln	40 ml/kgBB/24 jam	➤ Kebutuhan Cairan:	Anak BB<10 kg	100 ml/kgBB/24 jam	Jumlah kebutuhan cairan/24 jam	: _____ cc
	>6 bln-5 thn	30 ml/kgBB/24 jam		Anak BB 10-20 kg	1000 ml + (50 ml x (BB-10)) /kgBB/24 jam	Jumlah input cairan/24 jam	: _____ cc
	6-10 thn	20 ml/kgBB/24 jam		Anak BB >20 kg	1500 ml + (20 ml x (BB-20)) /kgBB/24 jam	Jumlah output cairan/24 jam	: _____ cc
	Dewasa	10-15 ml/kgBB/24 jam		Dewasa	50 ml/kgBB/24 jam	Balance cairan/24 jam	: _____ cc (Kelebihan / Kekurangan / Seimbang)*



Contoh penulisan Form Observasi Balance Cairan

Berat Badan : 60 kg

Diagnosa : HT, DM type 2, CKD

☐ Gagal Jantung

☒ Gagal Ginjal (CKD)

☐ Luka Bakar

☐ DHF

Tgl/ Jam	Input						Total Input (cc)	Output						Total Output (cc)	Selisih/Balance Cairan (Input-Output) (cc)	Kebutuhan Cairan (cc)	Paraf/ Inisial	Evaluasi
	Oral (cc)	NGT (cc)	Infus (cc)	Inj. (cc)	Transfusi (cc)	Cairan Lain (cc)		BAK (cc)	BAB (cc)	NGT (cc)	Muntah (cc)	IWL (cc/)	Cairan Lain(cc)					
07.00	100	-	50	5	-	-	155	-	-	-	-	10	25	35	120		DH	Kelebihan cairan, batasi pemberian infus selanjutnya atau evaluasi apakah pemberian oral/infus bisa dikurangi. Monitor tanda-tanda kelebihan cairan (edema, BTA, kenaikan berat badan)
08.00	200	-	300	-	-	-	500	350	-	-	-	10	-	360	140		DH	Tinjau kembali rencana infus/oral; cek tekanan darah, jantung, paru; diskusikan batas cairan dengan tim rawat/Uro.
12.00	150	-	250	-	-	-	400	300	-	-	-	5	50	355	45		DH	Kurang, tambah oral/infus ringan
16.00	200	-	200	-	-	-	400	250	-	-	-	10	-	260	140		SH	Kelebihan, pertimbangan pengurangan infus maintenance
20.00	100	-	150	-	-	-	250	200	-	-	-	10	-	210	40		SH	Kurang, monitor output dan tanda dehidrasi
24.00	-	-	250	-	-	-	250	200	-	-	-	5	-	205	45		FH	Kurang, monitor output dan tanda dehidrasi
04.00	-	-	200	-	-	-	200	150	-	-	-	10	-	160	40		FH	Kurang, bila pasien oliguri, waspadai penumpukan cairan



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

(Etiket Pasien)

Panduan:

➤ IWL:	0-6 bln	40 ml/kgBB/24 jam	➤ Kebutuhan Cairan:	Anak BB<10 kg	100 ml/kgBB/24 jam	Jumlah kebutuhan cairan/24 jam	: <u>3000</u> cc
	>6 bln-5 thn	30 ml/kgBB/24 jam		Anak BB 10-20 kg	1000 ml + (50 ml x (BB-10)) /kgBB/24 jam	Jumlah input cairan/24 jam	: <u>2155</u> cc
	6-10 thn	20 ml/kgBB/24 jam		Anak BB >20 kg	1500 ml + (20 ml x (BB-20)) /kgBB/24 jam	Jumlah output cairan/24 jam	: <u>1585</u> cc
	Dewasa	10-15 ml/kgBB/24 jam		Dewasa	50 ml/kgBB/24 jam	Balance cairan/24 jam	: <u>570</u> cc (Kelebihan / Kekurangan / Seimbang)*